

49 - 04-Sémiologie de l'épilepsie - Pr. Kissani

(0:01 - 0:24)

Donc, parmi les causes des troubles neurologiques paroxystiques, la principale cause, c'est l'épilepsie. Et donc, d'où le sujet du cours d'aujourd'hui, qui est la sémiologie de l'épilepsie et des crises épileptiques. Donc, tout d'abord, comme définition, il ne faut pas confondre une épilepsie avec une crise d'épilepsie.

(0:24 - 0:44)

Une épilepsie, c'est une maladie, une infection neurologique chronique d'étiologie biverse. Elle est caractérisée par la répétition des crises qui sont des décharges excessives d'une population de neurones corticaux. Alors qu'une crise, ça peut être un phénomène unique ou bien ça peut être deux phénomènes dans la vie d'une personne ou trois.

(0:45 - 1:01)

Et c'est très limité, donc ce n'est pas chronique comme dans l'épilepsie. Et elle peut être due à des causes accidentelles, par exemple, quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien sévère. Quelqu'un qui est alcoolique, il peut aussi faire une crise ou deux suite à son alcoolisme, à l'agression de l'alcool sur le cerveau.

(1:01 - 1:21)

Quelqu'un qui a fait un patient d'hérésie qui fait une hypoglycémie, elle pourra aussi entraîner une crise d'épilepsie. Ou bien les enfants, les nourrissons, quand ils font de l'affaire, ils peuvent aussi faire une crise accidentelle qu'on appelle des conditions fébriles. Ça aussi, ça rentre dans la crise d'épilepsie et pas l'épilepsie.

(1:21 - 1:44)

Et cette différence est fondamentale parce qu'on traite une épilepsie qui est une maladie chronique. Sinon, il y a beaucoup de risques de gravité, de chute mortelle, d'une crise, d'un état de mal épileptique, comme on va le voir, ou de gravité. La cause de l'épilepsie, si elle n'est pas traitée, alors qu'une crise accidentelle, il ne faut pas traiter la crise, mais plutôt traiter la cause de la crise.

(1:44 - 2:00)

Si c'est la fièvre ou autre chose et on ne traite qu'une épilepsie. Donc, il y a quatre éléments fondamentaux pour retenir qu'une crise, elle est d'origine épileptique, parce qu'il y a beaucoup de crises non épileptiques. C'est un coq, l'hypothémie, malaise, migraine et ainsi de suite.

(2:02 - 2:19)

Premier élément, il faut que ce soit un phénomène aigu parce que, comme on l'avait dit, c'est une décharge d'une population de neurones dans le cerveau, dans le cortex. Donc, ça va être exprimé par un phénomène aigu. Il faut qu'elle soit de début et de fin brusque vu que c'est une décharge électrique limitée dans le temps.

(2:19 - 2:29)

Donc, le début va être brusque. Par exemple, quelqu'un qui est assis et brusquement, il va tomber par terre. Il va commencer à faire des crises de tension des muscles, d'expansion ou de clonie.

(2:30 - 2:40)

Et la réussite va être brusque. Bien sûr, là, il ne faut pas mélanger la fin d'une crise et la fin des conséquences de la crise. Par exemple, une crise généralisée, elle peut prendre en général 2-3 minutes.

(2:41 - 3:00)

Mais vu la confusion avec la décharge tellement massive du cortex cérébral, normalement, là, la conséquence qui est la confusion post-critique, elle peut durer parfois plusieurs minutes, voire des heures après la crise. Et parfois, les patients, ils vous disent la durée, ils font la sommation de tout ça. Donc, une crise, c'est juste le phénomène initial.

(3:01 - 3:12)

Il faut que ça soit stéréotypé. Qu'est-ce que ça veut dire stéréotypé ? Il faut que ça se répète de la même manière chez le même patient. Donc, à chaque fois, il faut que ce soit les mêmes éléments qui se suivent.

(3:12 - 3:30)

Par exemple, un patient qui vous fait une crise clonique du manque supérieur droit, après, ça va être les myphases droites, après, les troubles de langage. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est stéréotypé. Quand le malade, vous posez la question sur la deuxième crise, la cinquième, la dixième crise, il faut que ça suive le même cheminement.

(3:30 - 3:43)

Ça veut dire que c'est la même propagation au niveau des cellules. Le cortical, par exemple, c'était au niveau de l'air de la frontale ascendante, la partie supérieure. Après, c'est descendu à la partie inférieure, qui est la partie de la face.

(3:43 - 4:00)

Et après, ça a touché la partie du langage, qui est juste à gauche aussi, vu que les crises sont à

droite. Et il faut que ça réponde à une logique anatomique, comme dans ce cas qu'on a expliqué. Par exemple, vu que ça touche les mycoses droites, c'est logique d'avoir l'aphasie parce que c'est l'hémisphère gauche qui est concerné.

(4:00 - 4:23)

Et on sait qu'un droitier, il a l'air de gros, quand il ouvre l'hémisphère gauche. Mais si, par exemple, vous avez un patient, juste pour donner un exemple d'un cas où il n'y a pas de logique anatomique, c'est par exemple dans les crises d'hystérie, vu d'ailleurs que ce n'est pas hypothétique. Donc, vous allez avoir une illogique anatomique, c'est-à-dire un patient, il va faire des crises des deux membres supérieurs, puis le membre inférieur, et puis la face droite, par exemple.

(4:24 - 4:40)

Il va crier, et là, il va avoir plutôt les yeux fermés, alors que là, il n'y a pas de logique anatomique parce que ça a touché les deux membres supérieurs, après le membre inférieur. Donc, un peu, c'est brouillant, surtout en logique anatomique. Les manifestations cliniques sont variées.

(4:40 - 4:56)

Et là, il faut savoir qu'il existe autant de manifestations cliniques que de fonctions cérébrales. Mais les plus fréquentes sont les pertes de connaissances, les phénomènes moteurs, comme dans les crises généralisées toniques, clonées, atoniques avec perte de tonus. Et sachez que le diagnostic est électroclinique.

(4:56 - 5:15)

Donc, c'est toujours la clé pour les éléments qu'on va voir. Et les données de l'EEG et le principe. Il est généralement, surtout en épidémiologie, sachez que l'épidémie, c'est la troisième maladie neurologique dans notre pratique, du fait de sa fréquence, après les céphalées et les accidents musculaires en Occident et même chez nous.

(5:16 - 5:34)

Sachez que sa prévalence, elle varie de 1 pour 1000 à 5,3% dans le monde. Et chez nous, au Maroc, elle varie de 0,5 à 1,1%. Donc, ça veut dire qu'on devra avoir, avec l'appropriation de 30 millions d'habitants, 360 000 cas d'épidémie.

(5:35 - 6:00)

Et sachez que la distribution, elle touche tous les âges, mais il y a depuis moins de 10 ans, on a vu la fréquence des maladies génétiques, héréditaires, anoxiques. Et aussi à partir de 75 ans, on a vu la fréquence des maladies cancéreuses et musculaires. Comment est-ce qu'on classe les épidémies ? Tout d'abord, on les classe sur le plan de la sémiologie, c'est-à-dire quels sont les

symptômes qu'on voit dans la crise.

(6:00 - 6:23)

Il y a par exemple des crises généralisées, des charges qui intéressent les deux hémisphères en même temps. Ça peut être des crises tonico-cloniques qui sont les plus impressionnantes et se manifestent par une perte de connaissance, avec chute, mouvements convulsifs, morsure de langue. Et là, vous pouvez voir la vidéo qui est attachée à ce fichier pour mieux voir une illustration des crises générales et tonico-cloniques.

(6:24 - 6:40)

Comme on l'a expliqué, elles ne doivent pas dépasser de 3 minutes et il ne faut pas mélanger la crise et la post-crise. Une fois la crise terminée, vous allez avoir des conséquences, plutôt la confusion post-critique, le relâchement, les courbatures, et tout ça. Donc là, c'est plutôt la post-crise et pas la crise.

(6:42 - 7:01)

Après, il y a les absences qui sont aussi des crises généralisées, avec suspension brève de la conscience, de quelques secondes. Elles sont parfois accompagnées de gestes involontaires et inadaptés, appelés automatismes. Par exemple, la personne qui commence à manipuler avec sa main ses vêtements, ou faire des mâchonnements, commence à mastiquer quelque chose avec ses lèvres, alors qu'il n'y a rien dans la bouche.

(7:02 - 7:12)

Sachez que les absences sont répétées de manière fréquente au cours de la journée. Après, surtout, c'est biologique toujours. Il y a les épilepsies partielles ou focales.

(7:12 - 7:23)

Et là, comme vous le voyez sur le schéma à droite, ça dépend des aires corticales. Vous allez avoir soit une atteinte, par exemple, de la frontale sondante. Et là, ça sera plutôt des phénomènes moteurs.

(7:23 - 7:34)

On voit au niveau de l'opère que ça sera de la demi-face, comme des mouvements de délimage, de pli du monde des yeux. La partie supérieure, ça sera le monde supérieur. En arrière, c'est le cortex somato-sensitif.

(7:35 - 7:45)

Ça sera plutôt des troubles sensitifs d'anémie du corps contre-latéral. En arrière, occipital, ça sera des phénomènes visuels. L'aire de Heschel, au niveau temporal, ça sera des phénomènes

auditifs.

(7:46 - 7:56)

On peut avoir aussi des vertiges. On peut avoir des troubles comportementaux au niveau frontale, et ainsi de suite. Sachez que les crises partielles représentent 60% au moins des épilepsies.

(7:57 - 8:13)

Initialement, les décharges paroxysmiques intéressent un secteur limité du cortex. Et sachez qu'une grande variété de symptômes peut être observée. Sachez que les crises partielles peuvent évoluer vers une crise généralisée tonico-clonique, ce qu'on appelle une généralisation secondaire.

(8:13 - 8:49)

Et crise partielle peut se traduire par des troubles moteurs, des troubles sensitifs, somatiques, sensoriels, bords, gustations, olfactions, ou des troubles cognitifs, troubles de mémoire, troubles dysmésiques, soit des crises hypermésiques, ou des crises amnésiques, ou des troubles phasiques, ou bien ça peut être des phénomènes psychiques, par exemple des problèmes de peur, de joie, de rire, et ainsi de suite. La deuxième façon de classer, c'est selon l'origine des épilepsies. Et là, il y a tout d'abord les épilepsies secondaires, qui sont plus symptomatiques.

(8:49 - 9:20)

Elles peuvent être tumorales, vasculaires, il y a un problème parasitaire, donc c'est des lésions connues qu'on trouve par l'imagerie qu'on fait, notamment l'imagerie par les ondes magnétiques nucléaires. Les deuxièmes, c'est des causes aussi symptomatiques ou secondaires, mais de causes inconnues, c'est-à-dire les épilepsies dont une cause est suspectée mais ne peut être trouvée par les moyens diagnostiques actuels. Par exemple, vous faites l'IRM avec un protocole épilepsie, ce n'est pas une IRM classique, les radiologues connaissent bien ça, et vous ne trouvez aucune cause détectable.

(9:21 - 9:32)

Et la troisième catégorie, c'est les épilepsies génétiques. Tout ça, c'est selon la nouvelle classification. Par exemple, pour les causes inconnues, on parlait avant du cryptogénique, mais maintenant on parle de causes inconnues.

(9:33 - 9:51)

Les causes génétiques, on parlait d'idéopathiques ou d'héréditaires, mais là on parle maintenant de génétiques. Et là, il concerne des sujets sans lésions cérébrales et qui présentent un caractère génétique avec des cas, un cousin, une cousine, un frère, les parents sont parfois

consanguins. Pour penser à cette origine génétique.

(9:53 - 10:28)

Quelles sont les causes des épilepsies? Les épilepsies symptomatiques sont dues à des lésions cérébrales, ça peut être des malformations congénitales, de la génération du cortex cérébral, des encephalites, des causes infectieuses, par exemple l'encephalite herpétique. Les séquelles d'une souffrance à la naissance, traumatisme crânien, ça peut être aussi un accident vasculaire cérébral, une tumeur, une infection du système nerveux central. Dans tous ces cas-là, c'est une lésion symptomatique que vous allez trouver par un imageur.

(10:29 - 10:49)

Au quotidien, des personnes bien sûr plus susceptibles de souffrir d'une épilepsie idiopathique ou héréditaire sont d'origine ou d'origine inconnue. En général génétique sont les enfants et les adolescents. Toujours un enfant et un adolescent, il faut chercher les causes génétiques plus que les autres origines.

(10:49 - 11:18)

Au Maroc, les principes pour facteurs étiologiques c'est tout d'abord les souffrances nées, on en a pas malheureusement, du fait des accouchements dans la campagne où il n'y a pas de gynécologue, les sages-femmes qui font des faux, l'arrivée tardive, aux hôpitaux ou plutôt au CHU. On a aussi les infections neuro-ménagères, encore la tuberculose qui fait encore quelques ravages chez nous, et les séquelles neurologiques, les accidents de la circulation. Par exemple, à Marrakech, on a beaucoup de motocyclistes qui ne mettent pas de casque et ont des traumatismes.

(11:19 - 11:54)

Parfois ça peut donner des conséquences graves avec l'épilepsie. Donc on va parler un petit peu des principaux syndromes épileptiques et bien sûr là, on va parler de la nouvelle classification de la Ligue internationale contre l'épilepsie, c'est le 2017, qui a remplacé toutes les précédentes qui ont démarré depuis 89. Et là par exemple, on commence par les épilepsies génétiques qu'on appelait avant élémentaires, elles sont souvent familiales, développent un psychomoteur tout à fait normal, un examen neurologique normal, intercritique, victime de foyers normaux, électroencéphalogramme et aucune lésion détectable par une AGI.

(11:55 - 12:39)

Et en général, ils sont de bons pronostics et répondent bien au traitement. La deuxième catégorie, c'est les épilepsies secondaires, qu'on appelait avant symptomatiques, et les différents syndromes épileptiques, donc ça dépend de la région du cerveau concerné, l'âge d'apparition des symptômes aussi va varier, le type de crise, la présence ou l'absence d'une maladie sévère d'islam, et là souvent vous allez avoir des aléoliens à l'examen clinique. Et là

troisième origine, c'est ce qu'on appelle les épilepsies d'étiologie inconnue, ce qu'on appelait cryptogénique dans les anciennes classifications, et depuis 2017 c'est d'origine inconnue, et là en fait on pense à une origine symptomatique comme le deuxième groupe, mais vous ne trouvez aucune lésion organique démontrable, il n'y a pas d'histoire ou de prédisposition génétique trouvée.

(12:40 - 13:20)

Là vous avez la référence de cette classification qui est à ce texte si vous voulez en voir plus en détail bien sûr pour peut-être vous nourrir votre culture générale avant ou surtout après les examens. Les points clés de cette nouvelle classification et donc qui a révisé un petit peu toutes les anciennes classifications, c'est qu'elle va nous donner différents niveaux, et tout d'abord le niveau diagnostique, par exemple le type de crise, après aller au type d'épilepsie, est-ce que les focales généralisées et généralisées, les focales combinées ou inconnues, et après le syndrome épileptique. Le deuxième niveau, un diagnostic étiologique doit être considéré dès le début de l'épilepsie et à chaque étape du diagnostic.

(13:21 - 13:52)

L'épilepsie d'une façon peut être classée dans plus d'une catégorie étiologique, d'une façon il peut avoir par exemple une origine inflammatoire et aussi une origine vasculaire, c'est par exemple ce processus, ce granulome inflammatoire qu'on croit dans le vaisseau. Et le terme bénin est remplacé par des termes d'auto-imité et pharmacosensibles à utiliser selon le contexte. Et aussi le terme d'encéphalopathie développementale épileptique peut être utilisé dans sa totalité ou en partie, encéphalopathie développementale ou encéphalopathie épileptique.

(13:53 - 15:02)

Et donc là, bien sûr, c'est la nouvelle classification un petit peu résumée, et là qui part avec quatre niveaux, donc toujours et vraiment elle est très très pratique, tant qu'on s'habitue bien sûr pour les neurologues et les épileptologues qui voient beaucoup de patients épileptiques, quand on raisonne tout d'abord, premièrement, selon la crise, la première ligne, c'est quel type de crise, est-ce que c'est focal, est-ce qu'il est focaux, est-ce que c'est généralisé, absence, généralisé tonico-clonique, généralisé tonique ou généralisé clonique, clonique c'est des secousses musculaires, tonique c'est des attitudes maintenues, atonique parfois, donc c'est des pertes de tonus, et bien inconnue, selon le type de crise. Après vous passez à l'épilepsie, c'est-à-dire en la classe 100, est-ce qu'elle est focale, est-ce qu'elle est généralisée, est-ce qu'elle est combinée généralisée focale ou inconnue, une fois que vous avez ça, là vous passez au syndrome épileptique. Donc de quel syndrome s'agit-il, et là par exemple, en parlant juste de l'enfant, on a par exemple le syndrome de West, le syndrome de Nox et Gasto, et ainsi de suite, et donc pour les gens qui maîtrisent l'épileptologie, ils vont rapidement savoir classer telle ou telle patient dans quel syndrome épileptique.

(15:03 - 15:36)

Une fois que vous avez classé, là, l'autre dimension, c'est l'étiologie. Donc en fait, là vous avez l'étiologie, c'est l'étape principale, là vous allez chercher, est-ce que c'est structurel, ou est-ce que c'est génétique, pour les causes à l'éviter avant, est-ce que c'est d'origine infectieuse, métabolique, par exemple, hypoglycémie, hyperglycémie, d'acidosectose thérapeutique par exemple, de cause auto-immune, par exemple en céphalite auto-immune, ou de cause inconnue. Ça c'est surtout l'étiologie avec les bilans et les examens complémentaires.

(15:37 - 16:54)

Et le dernier niveau, c'est les comorbidités, et ça c'est très très important, par exemple l'épilepsie d'un enfant, différent du sujet âgé, différent de la femme enceinte, différent par exemple de quelqu'un qui a un problème d'énergie à certains produits, et ainsi de suite. Donc juste quelques exemples résumés, selon l'âge, la sémiologie et la génétique, par exemple pour les différents syndromes épileptiques à connaître, là vous avez cette classification qui permet de classer selon l'âge, vous voyez par exemple un an, c'est le rang central, après de 1 mois, après de 1 mois à 2 ans, après de 2 ans à 10 ans, et ça dépend par exemple, tout ce qui est à droite c'est généralisé, à gauche c'est focal, et tout ce qui est au-dessus c'est plus idiopathique ou héréditaire, et tout ce qui est en bas c'est plutôt symptomatique. Et là vous avez les différents syndromes, par exemple là vous avez le syndrome de West comme on l'avait dit, donc entre 1 mois et 2 ans, d'accord, le syndrome aussi de l'involution se situe à ce niveau là, donc de 2 ans à 3 jusqu'à 10 ans, et donc c'est plutôt symptomatique, c'est pas idiopathique, et c'est généralisé, donc c'est après on pourra dire l'âge d'apparition, et c'est symptomatique, et qui est généralisé.

(16:56 - 19:27)

Donc là on va parler de quelques exemples, tout d'abord les épilepsies absence, qui touchent surtout l'enfant, l'adolescent, c'est des épilepsies généralisées génétiques, le contexte tout d'abord, c'est des enfants de 2 à 7 ans pour l'enfant, et de 8 à 12 ans pour les formes juvéniles, avec des antécédents familiaux dans 25% des cas, et surtout c'est la fille qui est touchée, dans les 3 quarts des cas. Là la sémiologie clinique, donc ça va être des crises sous forme d'absence, c'est-à-dire une rupture du contact, c'est comme quelqu'un qui est sidéré, donc qui ne regarde plus, qui ne répond plus, qui ne parle plus, à peine il respire, il a le regard figé, et avec parfois des clonies palpébrales dans 50% des cas, elles sont brèves, qui durent 10 à 60 secondes, très fréquentes, parfois 60 par jour, et ça, ça peut vraiment compromettre la scolarité de l'enfant, par exemple imaginez un enfant à l'école, et là il va faire des pertes de connaissances de 30 secondes, la question, la maîtresse lui pose une question, il perd la moitié de la question, c'est normal qu'il ne va pas pouvoir répondre, ou parfois il répond, il lit une récitation, il peut se bloquer pendant 30 secondes et après continuer, et là on a eu même des enfants parfois qui ont été giflés, ou chassés d'école parce que le maître d'école qui malheureusement ne connaît pas l'épilepsie croit qu'il faisait un peu le pitre, et ça en fait, on a une association d'épilepsie qui

essaie un peu de travailler, de sensibiliser dans ce sens, pour éviter ces conséquences fâcheuses, et surtout de bien diagnostiquer ces enfants, parce qu'avec un traitement tout va rentrer dans l'eau, les facteurs favorisants, c'est surtout les émotions, réveil et hyperpnée, et d'ailleurs ça c'est un test très facile à faire, l'hyperpnée, vous demandez à l'enfant de faire l'hyperpnée par exemple de respirer profondément des inspirations et des expirations profondes pendant 2 minutes, ne pas dépasser 2 parce que sinon ça va donner un vertige, et l'enfant bien sûr, parfois les petits enfants peuvent faire le moulin avant, plus il souffle et plus ça fait tourner le moulin avant et plus il fait l'hyperpnée, et après il va faire une absence, et là vous avez le diagnostic devant les yeux. Les signes électriques, donc l'activité de fond est tout à fait normale, et ça c'est un critère clé pour parler d'épilepsie bénigne, d'épilepsie génétique, anomalies critiques, vous allez voir des décharges généralisées, synchrones, c'est-à-dire synchrones c'est au même moment, au niveau de toutes les déviations et des électrodes, à titre de 0.3, à 3 cycles par seconde, 3 Hertz, à début d'effet brusque, la stimulation lumineuse, intermittent, et l'hyperpnée déclenche des crises.

(19:30 - 21:17)

Un deuxième exemple, c'est les épilepsies avec crise, grand mal de réveil, les épilepsies généralisées génétiques, donc c'est ça le regroupe actuellement dans la classification de 2017, le contexte, donc l'âge autour de la puberté, les signes cliniques, ça sera des crises généralisées, cloniques, pertes de connaissances, chutes, blessures, et là vous allez avoir la phase tonique, la phase tonique avec une attitude en extension de tous les membres, la personne en opistotonose, puis la phase clonique avec des secours des 4 membres, après la phase résolutive, le blocage de la respiration, parfois la personne a déjà mordu sa langue, il va reprendre une façon bruyante sa respiration, ce qu'on appelle la mousse aux lèvres, et donc une fois la crise terminée, là vous allez avoir la post-crise avec la confusion post-critique à plusieurs minutes voire quelques heures, le patient est fatigué, abattu, il a besoin de dormir, des courbatures partout, et la durée totale de la crise ne dépasse pas 3 minutes, et donc c'est pour ça que quand on pose la question à la famille, ils nous disent que c'est 2h, 3h, mais en général qu'est-ce qu'il se passe, ils mélangent la crise qui est formée par les 4 premières étapes, et la confusion post-critique qui est en fait plutôt les conséquences de la crise et de l'œdème cérébral, la congestion cérébrale, et parfois même l'IRM quand on la fait sur des anomalies qui témoignent d'une grande souffrance du cerveau après cette crise-là. Et les facteurs favorisants c'est surtout le réveil, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de réveiller brusquement les patients. Les épilepsies du long temporal, épilepsies secondaires ou de causes inconnues partielles, toute épilepsie qui débute avant l'âge de 25 ans, il faut la considérer comme épilepsie tardive, elle sera considérée comme symptomatique ou lésionnée jusqu'à preuve du contraire.

(21:17 - 23:03)

Elle débute dans l'enfance, parfois vous avez les épilepsies comme les crises temporales, la sclérose de l'eau de l'hippocampe, vous allez avoir une combustion fébrile, vous allez voir des

phénomènes neuro-végétatifs dans la crise, des sensations épigastriques, assombantes, qui sont très localisatrices pour l'opération temporelle, la peur qui localise vers la limite d'âme, ou bien vous allez voir des phénomènes sensoriels, illusions, hallucinations, olfactifs, gustatifs, auditifs, visuels, automatisme au roi alimentaire, les crises sont souvent partielles, complexes, avec altération de la conscience et ou automatisme. Donc là on a parlé des crises épileptiques, maintenant on va parler d'une situation très très grave qui est l'état de maladie épileptique, c'est quoi l'état de maladie épileptique, qui peut d'ailleurs compliquer chacune des crises qu'on a déjà vues, donc en fait c'est des crises continues et non-stop qui dépassent les 5 minutes, donc quand vous avez une crise, quand vous avez sur le schéma du milieu, donc là vous avez un état de mal très grave, sans traitement, donc si vous le traitez pas mal au revol, on prononce qu'il est très très mauvais, donc si vous prenez par exemple des crises généralisées, la première barre rouge, donc c'est la phase tonique, après la deuxième, c'est la phase chronique, après c'est la phase résolutive, donc tout ça c'est une crise, quand vous avez la première crise, puis suivi de la deuxième immédiatement, puis la troisième, la quatrième et ainsi de suite, sans retour à la normale, donc c'est ce qu'on appelle un état de mal épileptique. Et bien sur l'état de mal d'une crise généralisée tonique ou chronique, c'est le plus grave parce qu'il va y avoir un meuble même déjà après une première crise, imaginez après 5 ou 6 crises ou 10 crises ou une heure de crise, le cerveau va être en souffrance très très grave et les patients parfois même peuvent mourir de leur état de mal épileptique.

(23:04 - 23:59)

Et bien sur ça il faut le séparer d'une crise simple, ce qu'on voyait à gauche avec les trois phases tonique, chronique et résolutive, ou bien ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle les crises sub-intrantes, donc en fait c'est des crises avec un espace, une pause ou un arrêt des crises entre les deux crises, donc le patient retrouve un état normal, parfois partiellement, parfois totalement, ce qu'on appelle les crises sub-intrantes. Et ces crises sub-intrantes parfois c'est un signe d'alarme et de menace de rentrer vers un état de mal épileptique. Donc ça vraiment c'est une urgence médicale absolue, dès qu'on voit le malade il faut le prendre en urgence, en réanimation, en soins intensifs, et il faut lui administrer des médicaments comme le Valium, l'Urbani ou d'autres médicaments, le Valproaz injectable, le Filetoyl injectable, malheureusement il y a des produits qui ne sont pas disponibles au Maroc, il faut bien le garder à l'injectable, malheureusement disponible.

(24:00 - 29:58)

Et il ne faut pas compter bien sur, comme je vous l'ai dit, avec les crises sub-intrantes mais qui peuvent rapidement se virer vers un état de mal épileptique. On distingue bien sûr les états de mal convulsifs, tonico-cloniques ou toniques, cloniques ou atoniques et bien sûr ces états de mal sont une grande urgence et il y a aussi les états de mal convulsifs partiels, moteurs, sensitifs, par exemple dernièrement on avait vu une malade qui est venue pendant une heure en train de faire des crises motrices du monde supérieur droit avec troubles du langage, donc c'était des crises motrices et aphasiologiques et finalement c'était un tuberculant

hémisphérique gauche qui était responsable. Et en dernier lieu, bien sûr, la situation la plus difficile, c'est quand vous avez par exemple des malades dans le coma ou des malades en réanimation qui vous font un état de mal non-convulsif les plus déroutant et là ça peut être un état de mal aphasique, confusionnel et parfois c'est la réalisation de l'électroencéphalogramme en réanimation qui va le diagnostiquer afin de le traiter.

Donc ce qu'on dit aussi différentiel, il faut savoir éliminer tout ce qui n'est pas épileptique donc tout d'abord vous avez des problèmes non-organiques donc c'est un problème soit hystérique ou de conversion névropathique ou par exemple c'est des crises d'agitation de certains enfants des crises de pleurs il y a aussi le spasme du sanglots, c'est des enfants qui commencent à pleurer jusqu'à complètement perdre leur connaissance d'accord, donc ça bien sûr c'est des problèmes fonctionnels qui du fait de l'hypoxie cérébrale vont demander de perdre connaissance et bien surtout ce qui est problème organique là aussi il y a les causes neurologiques par exemple il y a aussi des phénomènes critiques, ça peut être une migraine, surtout la migraine avec aura, ça peut être le visuel qui dure quelques minutes là aussi il ne faut pas les mélanger avec la crise épileptique et là il y a une distinction facile à faire, c'est ce qu'on appelle la marche épileptique comme on l'avait vu qui se fait en secondes par exemple une crise ça va en secondes, au maximum une ou deux minutes alors que pour la migraine c'est une marche en minutes, c'est jamais en secondes donc c'est minimum 5 minutes et c'est maximum une heure pour l'aura migraineuse, par exemple vous allez avoir des patients qui vont avoir des étoiles lumineuses quand ils vont avoir la cfav comme des battements dans la moitié de leur crâne et surtout ils vont avoir des phénomènes visuels comme des points des sentiments, des lumières, parfois des scotons, des taches noires qui vont bouger de 5 à 60 minutes donc là il ne faut pas s'inquiéter, il faut rassurer le patient, c'est plutôt l'aura migraineuse qu'il faut bien traiter et c'est pas du tout épileptique on a aussi des problèmes extra-neurologiques ça peut être des causes cardio-vasculaires comme les syncope, comme la hypotémie, le choc vagal et ainsi de suite la syncope il faut retenir qu'elle est à l'emporte-pièce en général le patient perd connaissance c'est du fait d'un manque de circulation cérébrale suite à un problème cardiaque de valve, par exemple rétrécissement mitrale, aortique ou d'autres troubles, insuffisance cardiaque ou autre et le patient en fait dès que la volume il baisse le cerveau bien sûr il n'est plus vascularisé, il va perdre connaissance et rapidement après, dès que c'est rétabli il va retrouver connaissance, donc ça sera à quelques secondes mais sachez qu'il y a parfois des syncope convulsivantes des syncope néurysientes, une façon de perdre les urines, on peut parfois faire des petites conditions dont on ne peut pas les mélanger avec l'épilepsie donc je prends un examen complémentaire sachez que le G est obligatoire pour le diagnostic la neuroimagerie après c'est pour l'étiologie, pour la code d'épilepsie et il y a d'autres bilans comme l'hypoglycémie études chez le diabétique le G il a deux intérêts un intérêt diagnostique donc ça va montrer des anomalies paroxysmiques des pointes, ondes, cohérentes avec la présentation d'une crise épileptique le G normalement n'élimine pas le diagnostic de la crise épileptique et il faut savoir le demander dans les jours en général, après 1 à 3 jours après une crise, il est souvent très démonstratif mais sachez que le G peut être anormal que dans 30 à 70% des cas, 30% quand il est mal préparé et 70% des cas quand il est

bien préparé le G il a aussi un intérêt pronostic et de surveillance thérapeutique et on l'utilise ici les anomalies épileptiques caractéristiques le A c'est une pointe il y a des critères électriques surtout en voltage et amplitude tout à fait typique après vous allez avoir sur le B la pointe onde, vous voyez une pointe suivie d'une onde ça aussi c'est vraiment typique il n'y a que l'épilepsie qui donne ça il n'y a aucune autre maladie qui donne ça ou bien on sait que ça peut être une pointe lente et là la première phase, elle est de 100 millisecondes, vous voyez donc ce sera sa définition après vous allez avoir des polypointes en petit d et vous pouvez même avoir des polypointes en petit e donc tout ça c'est vraiment typique de l'épilepsie là vous avez une logique typique d'une épilepsie absence regardez avant le rythme de fond sur les 3 premiers centimètres et après vous avez les décharges à type de pointe onde comme je vous l'avais dit avant à 3 hertz et là vous allez voir vraiment ces pointes ondes agrandis ici donc vraiment c'est très très démonstratif une pointe suivie d'une onde et quand vous mesurez par rapport à une seconde vous avez 3 complexes et en conclusion sachez que l'épilepsie c'est une infection neurologique fréquente son diagnostic est électroclinique 80% revient à l'interrogatoire elle doit être connue de tout praticien généraliste ou spécialiste ou même aux étudiants de médecine la symbiologie des crises épileptiques est à connaître par tout praticien surtout généraliste le G doit être bien indiqué très bien fait et correctement interprété et par ses manifestations cliniques variées et parfois associées et parfois déroutantes et sachez que le pronostic est généralement très élevé